DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: LUCELLY HURTADO HERRERA **Identificación** CC 66723152
Edad: 53 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: QUIROFANO 2 **Fecha programación de cirugía:** 04/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	850101	DRENAJE EN MAMA DE COLECCION POR MASTOTOMIA O MAMOTOMIA	Y34	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	851201	BIOPSIA ABIERTA DE MAMA	Y35	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: MAMA IZQUIERDA

1	862006	DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL MENOR DEL 10% DE SUPERFICIE CORPORAL EN AREA GENERAL	Y38	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: MAMA IZQUIERDA

1	867002	COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL ENTRE DOS A CINCO CENTIMETROS CUADRADOS	Y38	

Cirujano: DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía: MAMA IZQUIERDA

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES100 DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

850101 DRENAJE EN MAMA DE COLECCION POR MASTOTOMIA O MAMOTOMIA
851201 BIOPSIA ABIERTA DE MAMA
862006 DESBRIDAMIENTO ESCISIONAL MENOR DEL 10% DE SUPERFICIE CORPORAL EN AREA GENERAL
867002 COLGAJO LOCAL SIMPLE DE PIEL ENTRE DOS A CINCO CENTIMETROS CUADRADOS

Dx Preoperatorio: N61X TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA

Dx Postoperatorio: N61X TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE LA MAMA

Tipo de Herida: CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 10 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 04/11/26 **Fecha Final** 04/11/26
Hora Inicio 22:30:00 **Hora Final** 22:50:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

1. PAUSA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA FIRMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO, PROFILAXIS ANTIBIOTICA.
2. BAJO ANESTESIA GENERAL, ASEPSIA Y ANTISEPSIA, COLOCACION DE CAMPOS QUIRURGICOS.
3. INCISION PERIAREOLAR. DRENAJE DE LIQUIDO PURULENTO NO FETIDO. SE TOMA MUESTRA DE SECRECION PARA CULTIVO.
4. DESBRIDAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS, HASTA EVIDENCIAR TEJIDO VITAL. QUEDA DEFECTO DE APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO.
5. LAVADO DE LA CAVIDAD ABSCEDADA CON SS 0.9% 1000 ML.
6. SE TOMA BIOPSIA DE TEJIDO MAMARIO, SE ENVIA A PATOLOGIA.
7. SE TALLAN COLGAJOS DERMOGRASOS PARA LOGRAR CIERRE DE LA HERIDA, COLGAJOS LOCALES SIMPLES DE PIEL ENTRE DOS A CINCO CENTIMETROS CUADRADOS.
8. SE INTRODUCE DREN DE PENROSE.
9. CIERRE DE LA HERIDA CON PUNTOS SIMPLES DE POLIPROPILENO 2-0. SE CUBRE LA HERIDA CON COMPRESA ESTERIL Y MICROPORE.

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

1. ABSCESO EN LA MAMA IZQUIERDA, HACIA LOS CUADRANTES SUPERIORES. DRENAJE DE LIQUIDO PURULENTO NO FETIDO, APROXIMADAMENTE 30 ML. 2. NECROSIS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO. 3. TEJIDO MAMARIO INDURADO.

Tejidos enviados a patología : **SI** [X] **NO** [ ]

BIOPSIA DE MAMA IZQUIERDA

OTROS PARTICIPANTES

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
ESP89	ALEJANDRO ERASO CHILANGUAD	ANESTESIOLOGO
MG267	JULIAN DAVID PELAEZ ARCILA	AYUDANTE

Diego F. Quintero Ladino
Cirujano General
Universidad Nacional de Colombia
CC 1.116.245.753

DIEGO FERNANDO QUINTERO LADINO
Reg. 17337
CIRUGIA GENERAL

***** FIN DEL REPORTE *****